PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA

ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA POR SECA E ESTIAGEM – ESTADO DO ACRE - 2024

SESACRE. Secretaria de Estado de Saúde
Elaboração: Núcleo de Determinantes Ambientais
Distribuição e informações
Secretaria de Estado de Saúde
R. Benjamin Constant, 830 - Centro
Rio Branco - AC. 69909-850
Quarto andar, lado A

Governador do Estado doAcre
Gladson de Lima Cameli

Secretário de Estado de Saúde
Pedro Pascoal Zambon

Secretária Adjunta de Atenção à Saúde
Ana Cristina Moraes da Silva

Secretária Adjunta Executiva - Administrativo
Andrea Santos Pelatti

Organização:

Secretária Adjunta de Atenção à Saúde
Diretoria de Regulação e Redes de Atenção à Saúde - DRAS
Departamento de Vigilância em Saúde – DVS

Secretária Adjunta de Assistência à Saúde
Ana Cristina Moraes da Silva

Diretor de Administração
Guilherme Miguel Texeira

Diretora de Gerenciamento de Unidades Próprias
Celene Maria Prado Maia

Diretora de Regulação e Redes de Atenção à Saúde
Relben Ferreira da Silva

Centro de Operações de Emergência em Saúde
Marcos Venicius Malveira de Lima

Departamento de Atenção Primária em Saúde
Érica Fabíola Araújo da Silva Faria

Departamento de Vigilância em Saúde
Adriana Maria Vieira Lobão

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – CIEVS
Débora dos Santos Gonçalves

Divisão de Vigilância Epidemiológica
Antonia Gerines Arruda Rangel

Divisão de Vigilância Sanitária
José Ribamar Queiroz de Souza

Divisão de Vigilância Ambiental
Junior Mota Pinheiro

Núcleo de Determinantes Ambientais
Regina Cláudia de Castro Cavalcante
Virna Tomás de Paula

Colaborações e Contribuições
Núcleo de Educação em Saúde – NUCES/DAPS
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST
Núcleo de Zoonoses
Núcleo de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar – NDTHA

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 6

2. INTRODUÇÃO 7

3. JUSTIFICATIVA 8

4. OBJETIVO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 9

5. ESTADO DO ACRE 10

6. VIGILÂNCIA EM SAÚDE 20

6.1 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 20

6.2 VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL 22

6.2.1 PROGRAMA VIGIDESASTRES 22

6.2.2 PROGRAMA VIGIAR 23

6.2.3 PROGRAMA VIGIAGUA 23

6.3 CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CIEVS 24

6.4 CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR – CEREST 25

6.5 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 26

6.6 DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 27

6.7 LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA – LACEN/AC 28

6.8 DIVISÃO DE IMUNIZAÇÃO – PNI/AC 28

7. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 28

8. COMUNICAÇÃO 30

9. GESTÃO 30

10. OUVIDORIA 31

11. ASSISTÊNCIA À SAÚDE 31

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 33

1. APRESENTAÇÃO

A seca e a estiagem são desastres naturais pertencentes ao grupo 4 (climatológicos), segundo a Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE. A estiagem é o "período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade, em que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição" (BRASIL, 2020a). Já a seca, "é uma estiagem prolongada, durante o período de tempo suficiente para que a falta de precipitação provoque grave desequilíbrio hidrológico" (BRASIL, 2020a). Tais eventos adversos são caracterizados como desastres graduais, por ocorrerem de forma lenta, se agravando de maneira progressiva ao longo do tempo (BRASIL, 2020a)

Os desastres decorrentes de seca prolongada afetam milhões de pessoas, contribuindo para a fome, a pobreza e a desnutrição, causando também surtos de doenças infectocontagiosas, doenças respiratórias, provocadas pelas queimadas e incêndios florestais, onde especialistas já alertam há tempos que o monóxido de carbono presente na fumaça pode acarretar problemas respiratórios, câncer, e doenças de transmissão vetorial, já que a crise nas redes de distribuição de água são contornadas com a utilização de reservatórios de armazenamento improvisados, podendo se tornar criadouros de mosquitos, dentre outras doenças, além de influenciar no processo de migração de populações.

Para reduzir os impactos dessa tipologia de evento sobre a saúde da população, é imprescindível o desenvolvimento de ações para o fortalecimento da capacidade de atuação em emergências em saúde pública associadas à seca e visando à garantia da prestação de serviços e à redução dos riscos à saúde da população. Urge-se ainda a necessidade de integração entre órgãos ambientais e de saúde das três esferas governamentais.

As consequências para a saúde, segundo os especialistas, atingem principalmente idosos e crianças, por conta, por exemplo, da maior suspensão de partículas na atmosfera, das altas temperaturas e da baixa umidade.A fumaça aumenta o número de internações de pacientes que já têm doenças crônicas. O calor dos incêndios pode levar à queima pulmonar. Além disso, tais poblemas se estende as populações indígenas e ribeirinhas.

Os efeitos indiretos da seca impactam em outros fatores condicionantes ou determinantes da saúde, que resultam na alteração do perfil de morbidade e mortalidade da população do território afetado, tais como:

- Baixo índice de chuva, que pode afetar a quantidade e a qualidade da água consumida pelapopulação;
- O comprometimento do sistema de distribuição de água e das fontes alternativas de abastecimento;
- A intermitência no fornecimento da água;

- A despressurização na rede de distribuição de água, com aumento da possibilidade decontaminação da mesma;
- A contaminação do ar por poeira e partículas oriundas de incêndios;
- A alteração nos ciclos dos vetores, hospedeiros e reservatórios de doenças são outras formasde exposições ambientais dos humanos decorrentes da seca.
- Recentemente, tem se constactado que o calor acentuado, principalmente na Região Norte tem aquecido faixas de rios alterando, assim o ph e a química da água e em função disso, ocasionando mortes de diversos peixes.

A alteração do perfil epidemiológico da localidade e a ocorrência de surtos e epidemias podem se constituir numa Emergência de Saúde Pública (ESP), e sobrecarregar os serviços de saúde locais, excedendo suacapacidade de resposta e a alteração no comportamento das doenças transmissíveis e não transmissíveis.

2. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, os desastres de origem natural estão se tornando cada vez mais presentes no cotidiano da população brasileira. Eventos de origem natural, como terremotos, ciclones tropicais, tornados, vendavais, inundações, estiagem e secas tendem a se constituir em uma ameaça e/ou perigo.

Quando acometem uma determinada região, causam maior adoecimento na população por agravos diversificados a depender de sua magnitude e intensidade, ocorrendo fatores de insalubridade, adoecimento, contato e/ou consumo de água contaminada, aglomeração de pessoas, descontrole ambiental de vetores, exposição a condições insalubres, dificuldades socioeconômicas, entre outros.

No Acre, especificamente, a situação se agrava devido a intensificação das queimadas e incêndios florestais no período entre maio e outubro, período de estiagem, e quando as queimadas se intensificam devido a atividade agrícola e pecuária.

As consequências das queimadas na Amazônia são muitas, e ameaçam vários aspectos do meio natural e do equilíbrio planetário.

Os instrumentos de Vigilância em Saúde Ambiental devem permitir a análise de informações relacionadas ao ambiente e a saúde, definindo indicadores com o objetivo de prevenir e atender a ocorrência de agravos. Sendo assim, como parâmetros norteadores da Vigilância em Saúde Ambiental, são utilizados alguns indicadores de agravos e doenças monitorados pela Vigilância Epidemiológica como também por órgãos externos ao setor saúde.

Como forma de melhorar e intensificar as ações de saúde frente ao impacto dos desastres e seus efeitos imediatos e a longo prazo sobre a saúde pública, deve-se aprimorar o conceito de

gerenciamento de risco no planejamento das ações de vigilância em saúde.

Um fator importante para o desenvolvimento dos trabalhos é o fortalecimento da intersetorialidade, onde a ação conjunta com os demais órgãos e entidades que atuam em desastres, possa exercer a universalidadedo sistema de saúde, visando favorecer a comunicação integrada e o bem-estar.

Denomina-se contingência, uma situação de incerteza, quanto a um determinado evento, fenômeno ou acidente, que pode se concretizar ou não, durante um período de tempo determinado, sendo assim, o Plano deContingência tende a ser elaborado a partir de uma determinada hipótese de desastre.

Havendo a hipótese de desastre, o Plano de Contingência deve ser elaborado, com o objetivo de organizar o setor saúde na prevenção, preparação, resposta e reabilitação aos desastres relacionados asecsa e estiagem, otimizando assim os meios necessários à assistência e ao monitoramento da população atingida, disponibilizando os recursos existentes, sejam eles privados, institucionais, humanos e materiais, previstos e disponíveis durante o cenário do desastre.

3. JUSTIFICATIVA

No Acre, a situação eminente de seca extrema ocorre entre maio e outubro, onde o nível das águas do Rio Acre tem registrado níveis críticos, como em setembro de 2001, quando o rio chegou a 1,50m, setembro de 2005, onde o rio atingiu a marca de 1,64 metros, setembro de 2016 com a marca de 1,30 metro e outubro de 2023 com 1,37 metro.

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PERÍODO DE SECA E ESTIAGEM 2023

No ano de 2023, o Estado Acre como um todo sofreu com a Estiagem severa, Incêndios Florestais e alto índice de Contaminação do Ar e ondas de calor. Desta forma, foi sugerido pela Defesa Civil Estadual que fosse decretado pelo governador do Estado do Acre, Situação de Emergência em todos os 22 municípios. Estimou-se que cerca de 500.000 pessoas foram atingidas de forma mais grave.

A crise hídrica ocorre quando a disponibilidade de água doce se torna insuficiente para atender às necessidades humanas e ambientais de uma determinada localidade, resultando na escassez de água potável.

O crescimento populacional, a mudança climática, a poluição, o uso excessivo e desperdício de água, dentro outros fatores, provocam o esgotamento de fontes de água, causando a crise hídrica. Sendo necessário, medidas de gestão e conservação da água, bem como a conscientização pública sobre o uso da água, a fim de garantir um suprimento sustentável de água para o futuro.

Um desafio crescente que afeta todo o Estado, colocando em evidência a importância crítica da água para a

vida humana, e ainda, para a sustentabilidade ambiental. A indisponibilidade de água para o consumo humano, também afeta a agricultura, indústria e ecossistemas naturais.

Localidades mais vulneráveis, são as mais afetadas pela escassez de água. Representando uma ameaça direta à saúde humana, com surtos de doenças relacionadas ao saneamento básico, devido à falta de água potável limpa e segura.

Resultado dos sucessivos efeitos da ação antrópica sobre o meio natural, faz com que a disponibilidade de água nos mananciais seja cada vez mais reduzida, além de afetar a qualidade da água do manancial, o que compromete o abastecimento de água potável para população.

Historicamente, o Estado do Acre sofre com os extremos hidrológicos, caracterizados pelos efeitos intensos da sazonalidade típica da região Amazônica. A alternância entre a estação chuvosa e a estação seca influência na vida das pessoas, nos ecossistemas e nas atividades econômicas do Estado.

Durante a estação chuvosa, de dezembro a maio, resulta em vários impactos ambientais notáveis, como as cheias de rios. Esse impacto tem se tornado cada vez mais comum, ocorrendo em mais de uma vez ao ano, causa enchentes e alagações. Quanto a estação seca, de junho a novembro, gera diferentes impactos, como incêndios florestais, migração de animais e a crise hídrica, causada pela irregularidade de chuvas nessa estação.

3.2 MUNICÍPIOS MAIS AFETADOS COM A CRISE HÍDRICA

Quadro 1-Panorama da crise hídrica nos municípios do Acre em 2023.

Município	Nome Da Comunidade	Quantidade De Carros Pipas
Acrelândia	Bairro Portelina Bairro do Lixão	1
Cruzeiro do Sul	Vila Liberdade Vila Santa Luzia Comunidades Juruá	3
Epitaciolândia	Bairro Pôr do Sol Bairro José Hassen Bairro Cemitério Bairro Liberdade Bairro Glória Bairro Saraiva Bairro Cetel	3
Mâncio Lima	Bairro São Vidal Bairro Cobal	1
Plácido de Castro	Zona rural	Não informado
Porto Acre	Vila Caquetá Vila Incra Loteamento Jardim	1
Sena Madureira	Bairro Vitória Bairro Jardim Primavera	1
Senador Guiomard	Bairro Naira Leite Bairro Chico Paulo Loteamento Jardim	1
Tarauacá	Bairro da Praia Beco da Garagem	1
Xapuri	Comunidade Sibéria	1

Rio Branco	Comunidade Panorama KM 07; Custodio Freire BR/364-KM 14; Vila Aquiles Perete – Ramal do Romão BR/364 – KM18; Adalto Frota – Garapeira BR/364 – KM 19; Vila Santos Dumint BR/364-KM 25; Ramal dos Cabral BR/364-KM 26; NiLson Josuá – Adalto Frota KM14;Ramal do Joca – Transacreana KM 03; Transacreana KM 05;Transacreana KM 07 – Ramal do Curica; Comunidade Manoel Marques KM 14; Comunidade Manoel Marques KM 14 e Particulares; Transacreana KM 19 – Ramal Aroeira e Ecológico Transacreana – KM 21; Transacreana – KM 23- Ramal da Melancia; Transacreana – KM 25 – Beco Dona Elza; Transacreana 27-Ramal Marizal; Transacreana KM 36 Beira da Estrada; Transacreana KM 40 Beira da Estrada; Transacreana KM 47 Ramal do Alberto; Transacreana KM 60 Vila Verde;Comunidade Maria Paiva de Moura – Porto Acre AC/10 KM 17; Comunidade Liberdade BR364 – KM/20; Comunidade Jarbas Passarinho – KM 18; Bairro Judia BR-364-KM 01; Comunidade Quixada KM 03; Comunidade Cinco Mil – KM 05; APADEQ -Estrada de Porto Acre – KM 06; P.A Baixa Verde; Àgua Preta; Apa do Amapá; Ass. de produtores rurais BR-364 e Ramal do Batista; Associação de produtores novo progresso; Associação de produtores rurais do Irineu Serra; Belo Jardim; Benfica Ribeirinho; Catuaba; Cidade do Povo; Espalha; Estrada AC – 10 – Estrada de Porto Acre; Estrada do Quixadá; Estrada Jarbas Passarinho; Extrema; Liberdade; Limoeiro; Moreno Maia; Oriente; P.A Colibri; P.A Barro Alto; P.A Carão e P.A Figueira; P.A e Polo Benfica; P.A Itamaraty – Transacreana KM 80; P.A Moreno Maia; P.A Vista Alegre; Ponorama; Panorama Ribeirinho; Polo Geraldo Fleming; Polo Hélio Pimenta; Ramal São Pedro e Ramal da Profe; Polos Custodio Freire e Nilson Josuá; Ramais Boa Àgua, Piranji, Peladeira, Sossego e Iquiri; Ramal àgua Preta e Ramal dois Irmãos; Ramal da União – Seracre; Ramal do Cacau;Ramal do Colibri; Ramal do Limoeiro; Ramal Extrema; Ramal Galiléia e Ramal Itucumã; Ramal Oriente; Ramal Santa Clara; Seringal Bagaço; Vai se ver; Vista Alegre;	Não informado

A seca é um desastre extensivo e sua duração pode variar de meses a anos, e seus efeitos sobre a saúde humana nem sempre são visíveis, é um evento climatológico, mas pode ser agravado pela ação do homem sobre o meio-ambiente, e um grande exemplo disso no Estado do Acre são as queimadas e incêndios florestais que ocorrem com frequência no período de estiagem, onde, dentre algumas consequências imediatas estão:

- Erosão e empobrecimento do solo;
- Eliminação da biodiversidade local;
- Diminuição da circulação do volume das águas superficiais;
- E mais recentente, o aquecimento das faixas de leitos dos rios, ocasionanto mortes de diversos animais de água doce, incluindo peixes;
- Alteração das condições de temperatura e umidade e presença de vapor d'água na atmosfera— chuva;

- Emissão de gases poluentes na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global e efeitoestufa;
- Alterações climáticas mundiais;
- Danos à saúde, como aumento de doenças respiratórias.

Seus impactos no desenvolvimento econômico, social e ambiental implicarão fortemente nos determinantes de saúde, principalmente no que se refere ao acesso a qualidade e quantidade de água potável e alimentação, além de consequências para a saúde física e mental das pessoas, contribuindo para a pobreza, desnutrição, surtos de doenças infectocontagiosas e respiratórias, transtornos psicossociais e migração de populações.

O objetivo deste Plano é subsidiar os gestores na tomada rápida de decisões a fim de reduzir os impactos provocados pelas secas e estiagens sobre a saúde das populações vulneráveis.

4. OBJETIVO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

4.1 GERAL

Organizar o setor saúde na prevenção, preparação, resposta e reabilitação, aos desastres relacionados a Sesa e Estiagem com a finalidade de otimização dos recursos necessários à assistência e ao monitoramento da população atingida.

4.2 ESPECÍFICOS

1. Promover ações permanentes, a partir de orientações às unidades de saúde do Estado e dosMunicípios;
2. Prevenir ou minimizar danos, a fim de assistir as populações atingidas, atuando na iminência ousituação de desastre;
3. Identificar, direcionar e fortalecer ações de atenção integral à saúde da população atingida pordesastres, incluindo a atenção psicossocial;
4. Intensificar a articulação e integração intersetorial;
5. Estabelecer fluxo de comunicação dialógica e fortalecer a participação social;
6. Reduzir a exposição da população e dos profissionais de saúde frente aos impactos que esseseventos possam causar;
7. Fortalecer a capacidade de preparação dos serviços de saúde para responder aos possíveisimpactos;
8. Aumentar a resiliência da população e da gestão do setor saúde;

9. Preparar as comunidades para futuros eventos;
10. Fortalecer a participação integrada dos setores e entes envolvidos no processo;
11. Fortalecer a participação comunitária na elaboração e execução de ações.

5. ESTADO DO ACRE

O Estado do Acre possui 22 munícipios a saber: Rio Branco (Capital do Acre), Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Acre, Epitaciolândia, Acrelândia, Porto Walter, Capixaba, Bujari, Manoel Urbano, Jordão, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus. O Acre conta com três Regionais de Saúde – Baixo Acre e Purus, Alto Acre, e Juruá/Tarauacá/Envira.

A população do Estado do Acre está estimada em 906.876 pessoas (IBGE 2021), com área territorial igual a 164.173,43 K m^2 (IBGE 2021), densidade geográfica de 4.47 hab./Km^2 (IBGE 2010), correspondente a 4,26% da Região Norte e a 1,92% do Território Nacional (IBGE 2010). As cidades mais populosas são Rio Branco,com 419.452 pessoas, Cruzeiro do Sul com 89.760 pessoas, Sena Madureira com 47.168 pessoas, Tarauacá com43.730 pessoas e Feijó com 34.986 pessoas, de acordo com o censo IBGE/2021.

O Estado do Acre está situado num planalto com altitude média de 200m, localizado no sudoeste da Região Norte, entre as latitudes de -7°06´56 N e longitude - 73º 48' 05"N, latitude de - 11º 08' 41"S e longitude - 68º 42' 59"S, fazendo fronteira com os países Peru e Bolívia, e divisa com os estados do Amazonas e Rondônia.

5.1 QUALIDADE DO AR X SAÚDE

Anualmente o Acre passa por um período de estiagem. A cada começo do período seco, também conhecido como “verão amazônico”, é comum que a população enfrente meses difíceis, com muita fumaça, altas temperaturas, baixa umidade do ar e uma grande sensação de desconforto.

A cultura do fogo, “facilita” a vida de muitos proprietários de terrenos baldios, pessoas que desejam se desfazer de entulhos acumulados em seus quintais e agricultores, já que é no campo onde ocorrem grandes queimadas, culminando na contaminação excessiva do ar.

Para entender melhor sobre os padrões de qualidade do ar, a Resolução CONAMA nº 491/2018, tem o objetivo de prover um instrumento de gestão da qualidade do ar, ajudar na medição de poluentes presentes e introduzir os efeitos de cada condição do ar sobre a saúde humana.

O índice de qualidade do ar nos permite entender os níveis de poluição atmosférica concentradas em ambientes internos e externos, e as propriedades que tornam o ar impróprio, ofensivo e danoso a saúde

e ao meio ambiente .

5.2 ESTRUTURA DO ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR

Classificação[1]	Concentração(µg/m3)					
	MP_{10} 24h	$MP_{2,5}$ 24h	SO_2 24h	NO_2 1h	O_3 8h	CO 8h
BOA	0 - 50	0 - 25	0 - 20	0 - 200	0 - 100	0 - 10.000
MODERADA	>50 - 100	>25 - 50	>20 - 40	>200 - 240	>100 - 130	>10.000 - 13.000
RUIM	>100 - 150	>50 - 75	>40 - 365	>240 - 320	>130 - 160	>13.000 - 15.000
MUITO RUIM	>150 - 250	>75 - 125	>365 - 800	>320 - 1.130	>160 - 200	>15.000 - 17.000
PÉSSIMA	>250	>125	>800	>1.130	>200	>17.000

5.3 QUALIDADE DO AR E EFEITOS NA SAÚDE

Qualidade	Significado
Bom	Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A população, em geral, não é afetada.
Moderada	
Ruim	Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar efeitos mais sérios na saúde.
Muito Ruim	Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda falta de ar e respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas).
Péssima	Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis.

5.4 SITUAÇÃO DO ACRE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL

O Acre ocupa o 5º lugar no ranking dos estados da Amazônia Legal que mais apresentaram focos de queimadas no ano de 2023, com 6,65% do percentual, totalizando 6.552 focos.

A Figura 1 apresenta o acumulado de focos de queimadas na AMAZÔNIA LEGAL, do início do ano (01/01/2023) até (31/12/2023). Foram registrados 98.646 focos de queimadas segundo o Satélite de Referência (AQUA), dos quais o estado de Pará apresentou maior percentual (42,29%) com total de 41.719 focos, seguido por Mato Grosso (12,94%) com 12.768 focos, Amazonas (19,87%) com 19.604 focos. (INPE, 2023).

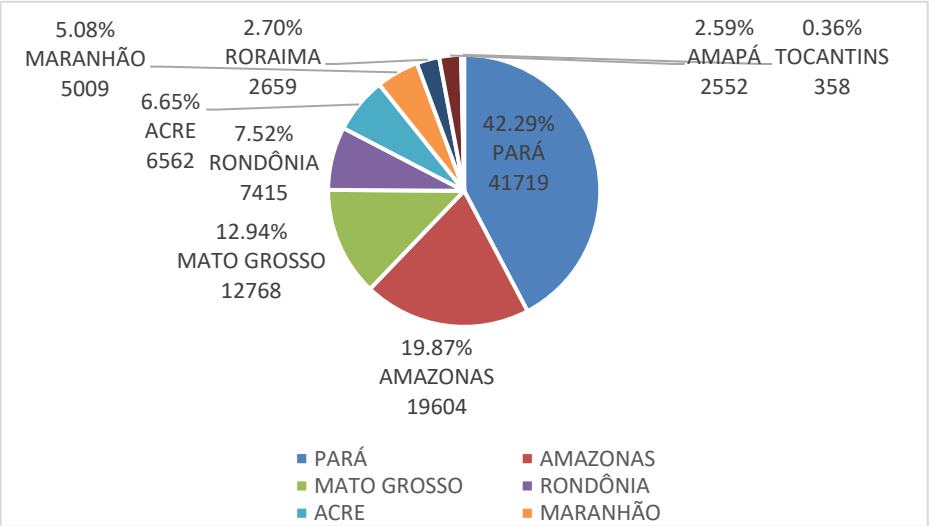


Figura 1 – Distribuição percentual dos focos de queimadas acumulados em 01/01/2023 a 31/12/2023 naAmazônia legal. (Fonte: INPE/Satélite de Referência AQUA).

5.5 SITUAÇÃO DE QUEIMADA NO ACRE EM 2023

No estado do Acre em 2023 , foram registrados um total de 6.562 focos de queimadas, de acordo com o Satélite deReferência-**AQUA**. O município de Feijó continua sendo o município com maior número de focos (1.207), com percentual de 18,39%, seguido por Tarauacá, que apresentou hoje 966 focos (14,72%); Sena Madureira com 593 focos (9,04%); Rio Branco com 543 (8,27%) e Cruzeiro do Sul com 536 (8,17%), sendo estes os principais municípios do estado em números de focos de queimadas.

Neste sentido, os municípios citados acima tornam-se prioritários para monitoramento e ações que possam amenizar os efeitos agudos e crônicos da exposição a poluentes atmosféricos.

5.6 FOCOS DE QUEIMADAS POR MUNICÍPIO EM 2023

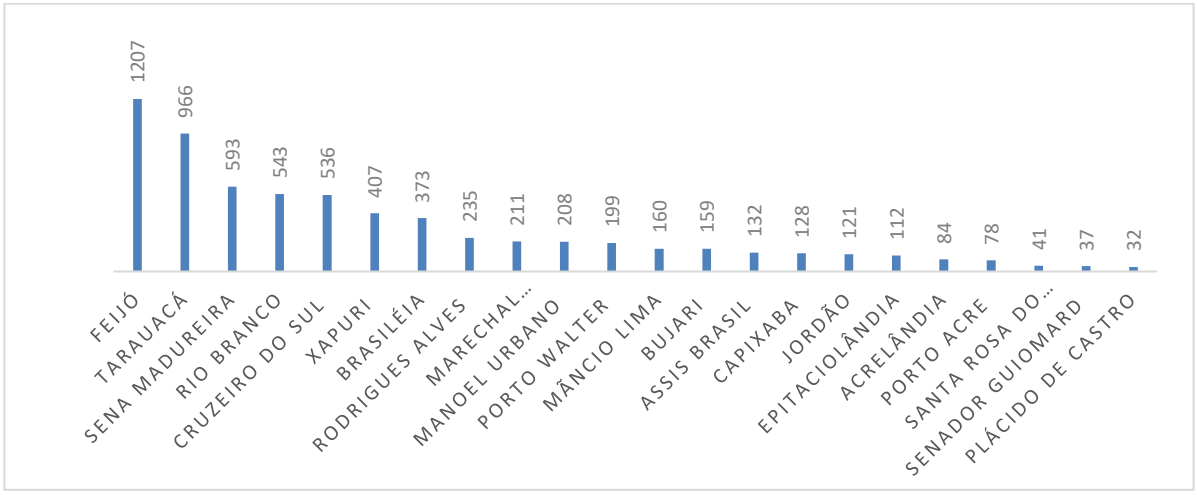


Figura 2 –Número de focos de queimadas em 2023 no estado do Acre (Fonte: INPE/Satélite de Referência AQUA).

5.7 INTERNAÇÕES POR FAIXA ETÁRIA OCORRIDAS NO ANO DE 2023

A **figura 3** mostra que a faixa etária de 1 a 9 anos é a mais acometida por influenza por vírus não especificados, pneumonias por microorganismos não especificados, bronquiolite aguda, doenças crônicas das amigdalas e adenoides e asma, enquanto a faixa etária de 50 a 80 anos é mais acometida por doenças pulmonares obstrutivas crônicas – DPOC.

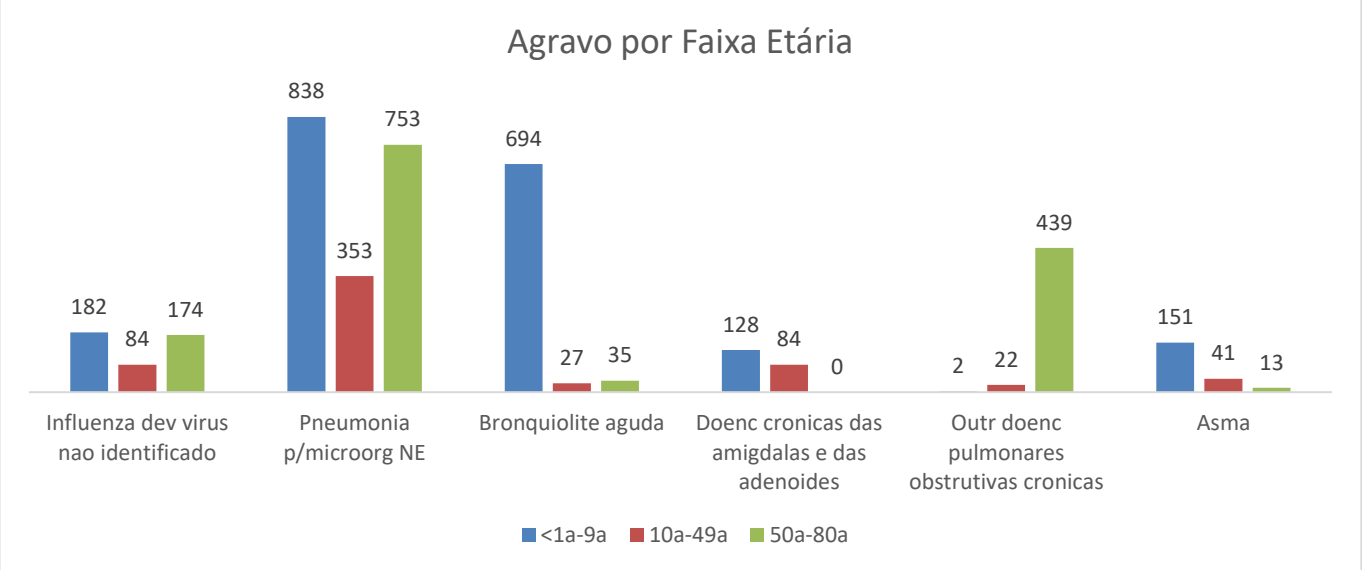


Figura 3 – Internações por faixa etária segundo agravo ocorridas no ano de 2023(FONTE:SIHD2/DRCAA/SESACRE)

Atualmente, vale mencionar que boa parte da população dos grandes e médios centros urbanos é composta por idosos e crianças, justamente o grupo mais suscetível aos efeitos nocivos da poluição. Em crianças,a poluição atmosférica pode resultar em significativas ausências à escola, diminuição nas taxas de

peak flow (Eficácia da função pulmonar, indicando quão abertas estão as vias respiratórias ou quão difícil é respirar), e aumento do uso de medicamentos em indivíduos que sofrem de asma. Nas pessoas normais, sejam elas adultas, crianças, ou idosos, a poluição ocasionara mudanças no sistema imunológico (Martins, 2002), além da deterioração da qualidade de vida, ocasionando mais idas a centros médicos, faltas na escola e/ou trabalho, além da restrição a prática de atividades físicas ao ar livre.

5.8 INTERNAÇÕES POR MÊS E AGRAVOS DE MAIOR PREVALÊNCIA EM 2023

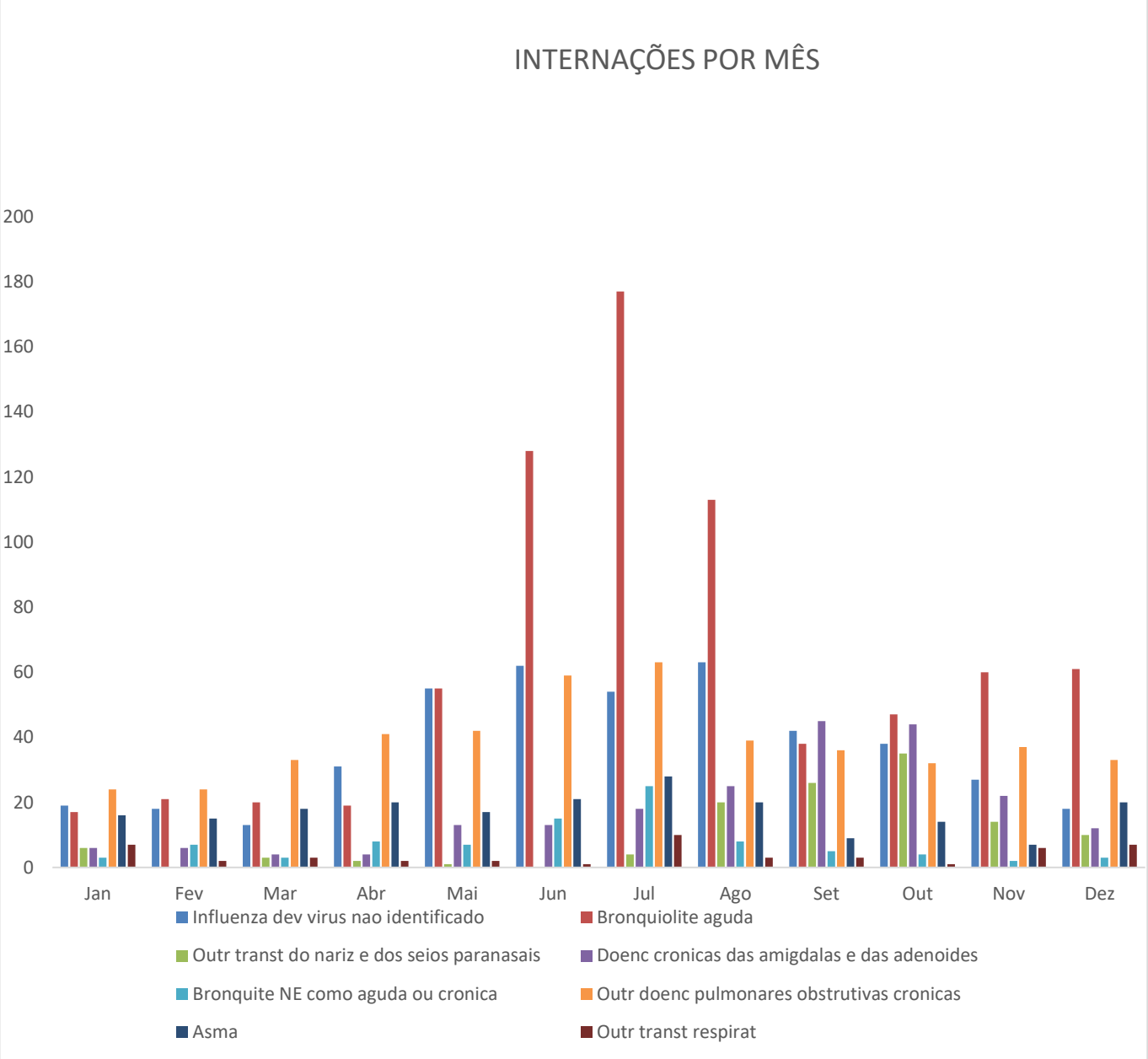


Figura 3 – Internações por doenças respiratórias de maior prevalência em 2023.
(FONTE:SIHD2/DRCAA/SESACRE)

A **figura 3** mostra a frequência de internações por mês de processamento ocorridas no ano de 2023, causadas por algumas doenças do aparelho respiratório. Observa-se que entre maio e outubro, justamente no

período de seca e estiagem, ocorre um acréscimo no número de internações, podendo sinalizar uma relação com a baixa qualidade do ar.

Segundo a OPAS e OMS, “é importante saber que o tamanho e o tipo das partículas poluentes inaladas determinam o lugar em que elas são alojadas no corpo. Consequentemente, determina também o tipo de doença que pode se desenvolver. Por exemplo, partículas grandes podem ficar presas no nariz, mas partículas muito finas podem chegar aos pulmões. Nos pulmões, elas se dissolvem e podem ser absorvidas para a corrente sanguínea. Além disso, o grau de exposição ao poluente e sua concentração no ar também são determinantes.

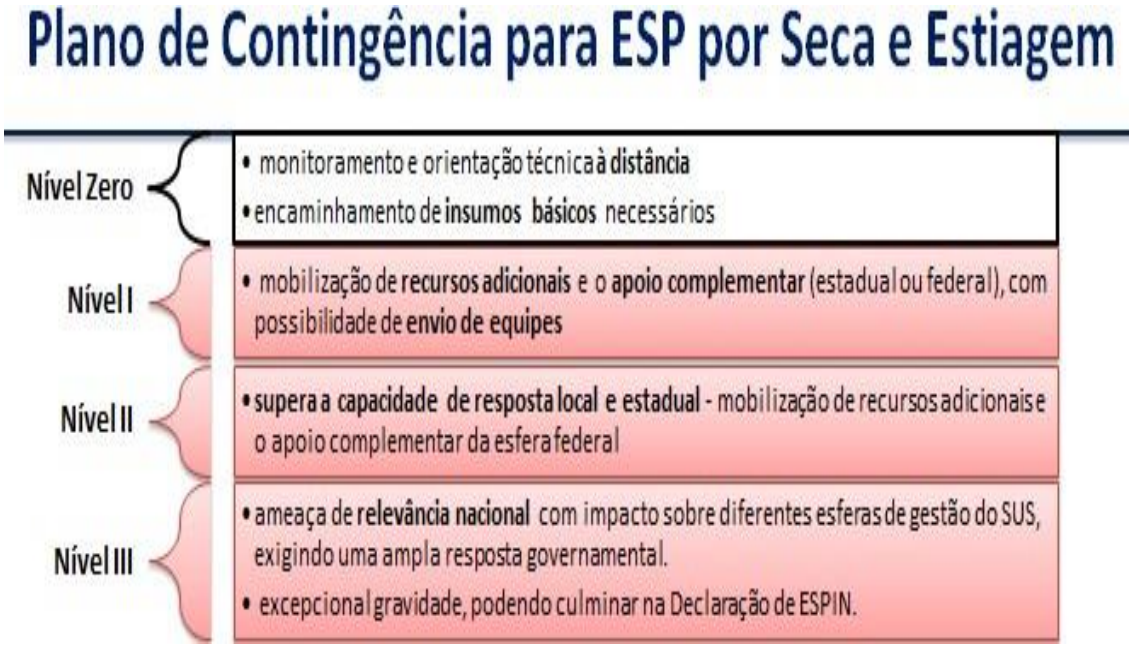
A seguir, os principais distúrbios ligados ao ar contaminado:

- Doenças pulmonares: Pneumonia, asma, bronquiolite e falha no desenvolvimento pulmonar em crianças são algumas das disfunções geradas pelo ar contaminado. Há muitas evidências de que a exposição de uma pessoa grávida a poluentes atmosféricos prejudica a função pulmonar do feto e impede seu amadurecimento, até mesmo a baixos níveis de exposição. Para mais informações sobrea saúde infantil em um contexto de poluição do ar, acesse esse documento da OPAS.
- Doenças cardiovasculares: No caso das doenças cardiovasculares, o material particulado deve receber uma atenção maior. Os impactos desse poluente na saúde estão relacionados à mortalidade por doenças cardiovasculares, como infarto do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais. Nesse estudo, por exemplo, percebeu-se uma íntima relação entre mortes de idosos residentes na Amazônia e a qualidade do ar. Esse fato se deve, principalmente, às queimadas na região amazônica. Além disso, as principais sociedades de cardiologia do mundo também apontam para aqualidade do ar como um fator importante para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Nesse artigo, emitido pela World Heart Federation (WHF), American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA) e European Society of Cardiology (ESC) foi declarado com todas as palavras: a poluição do ar agrava a Covid-19 e as doenças cardiovasculares e é preciso que as entidades médicas tomem medidas para diminuir esses efeitos.
- Câncer: Já em 2013 a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) publicou o documento nº161, reconhecendo a poluição do ar como um fator de risco cancerígeno muito alto, tanto em humanos como em animais. Esse estudo aponta que 19% de todos os cânceres estimados são atribuídos ao meio ambiente, inclusive o ambiente de trabalho, resultando em 1,3 milhões de mortes por ano. Em relação ao câncer infantil, nesse artigo, foi evidenciado o aumento do risco de leucemia em crianças, quando existe contato com poluição do ar originada do tráfego de veículos

- Agravamento da Covid-19 relacionado a doenças cardiovasculares: As principais sociedades de cardiologia do mundo reconhecem que a poluição do ar agrava os casos de

covid-19. Outras pesquisas foram conduzidas nesse sentido, demonstrando as consequências do contato com poluentes atmosférico em um curto e longo espaço de tempo.

Diante desse cenário, a SESACRE, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental, Programa VIGIDESASTRE e demais áreas técnicas, considera necessário a elaboração desse instrumento denominado “Plano Estadual para Emergência em Saúde Pública por Seca e Estiagem”, bem como fomenta a elaboração de tal instrumento por parte dos municípios do Estado.



- **Nível de Respostas Zero: Monitoramento de Eventos**

Indicadores de monitoramento da emergência: Neste nível de emergência, a esfera Estadual se restringe ao monitoramento do evento e à orientação técnica à distância.

Serão monitorados, durante a vigência da emergência, os alertas da Defesa Civil, o prognóstico da baixa precipitação de chuva e a ocorrência de surtos de doenças. Além disso, será realizada a captura de rumores na mídia.

- **Nível de Respostas I – Emergência Localizada**

Neste nível de emergência, a esfera estadual se restringe ao monitoramento e à orientação técnica à distância, bem como ao encaminhamento de insumos básicos, quando solicitados.

Serão monitorados durante a vigência da emergência os alertas da Defesa Civil, o prognóstico dos próximos períodos de estiagem e os indicadores epidemiológicos de incidência para doenças e agravos relacionados à seca e estiagem.

- **Nível de Respostas II – Emergência Expandida**

Neste nível de emergência, a capacidade de resposta da esfera municipal é excedida, sendo necessária a mobilização de recursos adicionais (materiais e humanos), bem como apoio complementar da esfera estadual.

Serão monitorados durante a vigência da emergência: alertas da Defesa Civil, o prognóstico de períodos de estiagem, os indicadores epidemiológicos de incidência das doenças relacionadas à seca e estiagem, bem como dados de mortalidade.

- **Nível de Respostas III – Emergência Nacional**

Neste nível de emergência, há necessidade da mobilização de recursos adicionais e o apoio complementar da esfera federal, assim como o acionamento de instituições parceiras, podendo culminar na declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN).

Serão monitorados, durante a vigência da emergência, alertas da Defesa Civil, o prognóstico de períodos de estiagem, os indicadores epidemiológicos de incidência de doenças e agravos relacionados às secas e estiagem, assim como dados de mortalidade.

6. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

6.1 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

6.1.1 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR (DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS, CÓLERA, FEBRE TIFOIDE, HEPATITE A, (está no nucleo IST'S), ROTAVIROSE, NOROVÍRUS, TOXOPLASMOSE E SURTOS DE DTHA)

- Intensificar as ações de Vigilância Epidemiológica das Doenças de Transmissão Hídrica;
- Garantir a distribuição de material educativo com ênfase nas recomendações relacionadas às DTHA;
- Apoiar a investigação de surtos e aglomerado de óbitos de doenças de veiculação hídrica e alimentar;
- Acompanhar a distribuição do hipoclorito de sódio a 2,5% para a população sem acesso à água tratada e orientar quanto à sua utilização;
- Realizar análise e divulgação semanal da situação das diarreias nos municípios.

- Incentivar coletas de amostras laboratoriais;
- Incentivar a parceria com as equipes de educação em saúde, atenção primária e Nucleo Hospitalar de Epidemiologia;
- Solicitar aquisição de material para coleta de amostras (Swab plástico com cary-blair, coletores)
- Acionar as áreas envolvidas na investigação epidemiológica a partir de notificação de surto de DTHA;
- Promover as ações necessárias ao controle e prevenção dos surtos no seu nível de competência;

6.1.2 NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR – RENAVEH

Em relação a contribuição da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar-RENAVEH, propomos um olhar diferenciado nos acidentes de trabalho que envolvem seca e estiagem, pois muito trabalhadores tem sua ocupação em locais que favorecem tais acidentes.

Considerando que A Lei nº 8.213/91 define acidente de trabalho como: "(…) o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho (…), provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho". Portanto, tais acidentes devem ser notificados por se tratar de ser uma Doença de Notificação compulsória e/ou evento de saúde pública, conforme Portaria GM/MS Nº420 de 02/03/2022.

6.1.3 NÚCLEO DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇASRESPIRATÓRIAS

- Desenvolver ações para interromper a cadeia de transmissão de Doenças Respiratórias;
- Promover reuniões com gestores municipais sobre a situação epidemiológica das doenças respiratórias relacionadas as queimadas;
- Elaborar e disponibilizar dados atualizados sobre as doenças respiratórias relacionadas com apoluição do ar;
- Apoiar as ações da vigilância frente à investigação de casos de doenças respiratórias na esferamunicipal e estadual;
- Intensificar o monitoramento nas populações vulneráveis e com condições clínicas de risco àsaúde, bem como: crianças menores de 5 anos, idosos maiores de 60 anos e gestantes, pessoas com problemas cardíacos, respiratórios, imunológicos entre outros;
- Recomendar a busca de atendimento médico na presença de sintomas de síndrome gripal;

- Garantir o medicamento Oseltamivir/Tamiflu, conforme protocolo clínico nas unidades básicas de saúde;
- Estimular e subsidiar a capacitação de profissionais de saúde quanto à prevenção e à assistência à saúde referente aos agravos causados e/ou influenciados pelas queimadas;
- Auxiliar na produção de material educativo e de comunicação sobre a ocorrência local de focos de calor, visando à promoção e à proteção à saúde, e a redução de riscos pelos efeitos nocivos dos poluentes atmosféricos;
- Investir na comunicação como forma de prevenção, como, por exemplo, elaborar e distribuirmateriais educativos (cartilhas, folders, boletins, spot de rádio) à população e aos profissionais de saúde, principalmente sobre os riscos à saúde humana frente as queimadas.

6.1.4 RECOMENDAÇÕES À POPULAÇÃO EM GERAL

- Evitar, sempre que possível, a proximidade com incêndios;
- Manter uma boa hidratação;
- Manter os ambientes da casa e do trabalho fechados e umidificados com o uso de vaporizadores, bacias com água e toalhas molhadas;
- Evitar a exposição ao sol;
- Usar máscaras ao sair na rua;
- Evitar aglomerações em locais fechados;
- Optar por uma dieta leve, com a ingestão de verduras, frutas e legumes, também estãoindicados;
- Além disso, em caso de urgência deve-se buscar ajuda médica imediatamente.

6.2 VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

6.2.1 PROGRAMA VIGIDESASTRES

- Coordenar as ações de resposta frente às necessidades identificadas;
- Mobilizar as áreas técnicas para desenvolver suas atribuições em relação ao Plano de Contingência
- Atualizar o Plano de Contingência Estadual anualmente;
- Auxiliar na criação dos Planos de Contingência municipais;
- Reduzir efeitos nocivos das queimadas sobre a morbimortalidade através de ações educativas preventivas orientando às SMS;

- Acompanhar os indicadores de qualidade do Ar fornecidos pelas instâncias estaduais, Secretaria de Vigilância em Saúde – Ministério da Saúde;

- Identificar áreas mais vulneráveis ao risco de introdução e propagação das Doenças Respiratórias
- Reduzir efeitos nocivos das queimadas sobre a morbimortalidade através de ações educativas preventivas orientando as SMS.

Obs: todas as açoes do VIGIDESASTRES estão prevista no Manual Operacional do VIGIDESTRES.

6.2.2 PROGRAMA VIGIAR

- Identificação e priorização dos municípios de risco de exposição humana a poluentesatmosféricos;
- Definição de áreas de atenção ambiental atmosférica de interesse para a saúde;
- Identificação dos efeitos agudos e crônicos da exposição a poluentes atmosféricos para acaracterização da situação de saúde.

6.2.3 PROGRAMA VIGIAGUA

O Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua) visa garantirà população o acesso à água em quantidade suficiente e com qualidade compatível com o padrão de potabilidade estabelecido na legislação vigente, para reduzir a morbimortalidade por doenças e agravos de transmissão hídrica e, consequentemente, garantir a promoção da saúde.

Em situações de emergências em saúde pública por seca e/ou estiagem, como a escassez hídrica, a atuação da vigilância da qualidade da água para consumo humano é dificultada, pois o desafio é buscar soluçõesque compatibilizem a necessidade de economia de água com proteção sanitária e, consequentemente, proteçãoda saúde humana, sem perder de vista as ações estruturantes que precisam ser desenvolvidas pelo setor saneamento para assegurar o acesso à água, em quantidade e com qualidade, para toda a população.

Dentre as ações desenvolvidas pelo programa VIGIAGUA, em situação de emergência por seca e estiagem estão:

- Intensificar a vigilância da qualidade da água para consumo humano nas áreas de risco, devido ao caráter emergencial priorizando as análises de cloro residual e E. coli ou coliformes termotolerantes;
- Indicar outras fontes seguras de abastecimento de água, destacando-se que a utilização de caminhões-pipa deverá obedecer às normas sanitárias;

- Assegurar o acesso ao hipoclorito de sódio a 2,5% para desinfecção caseira da água para consumo humano;
- Apoiar os municípios na divulgação sobre os procedimentos de limpeza e desinfecção das caixas

  d' água;
- Orientar os responsáveis pela operação dos sistemas de abastecimentos, sobre como procederem caso de desabastecimento público em soluções alternativas coletivas, para elaborar um plano emergencial de monitoramento da qualidade da água no período de contingência, visando assegurar a manutenção adequada dos sistemas de abastecimento;
- Informar aos responsáveis pelos sistemas de Esgotamento Sanitário sobre a necessidade de: consertos de tubulação, desentupimento de galerias, drenagem e limpeza de estações de tratamento, cloração e desinfecção de efluentes, construção de instalações sanitárias nos acampamentos e abrigos temporários;
- Indicar a utilização de soluções alternativas de abastecimento, no caso de algum manancial normalmente utilizado ter sido contaminado por substâncias perigosas;
- Manter articulação com as unidades de emergência (hospital e pronto atendimento) para alertar sobre o possível aumento no número de casos de doenças de transmissão hídrica, especialmente Doença Diarreica Aguda, e aumento do número de casos de transtornos psicossociais e comportamentais.

6.3 CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CIEVS

- Identificar emergências epidemiológicas, de modo contínuo e sistemático, por meio de notificações telefônicas, eletrônica e mineração de informações nos principais meios decomunicação (informes Diários, Boletins semanais ou quinzenais, Clippings);
- Receber a comunicação do evento, sendo o ponto focal intersetorial da Secretaria de Estadode Saúde;
- Coletar, consolidar, monitorar e disseminar as informações desses eventos entre os gestoresmunicipais;
- Mobilizar as áreas técnicas para desenvolver suas atribuições em relação ao Plano de Contingência;
- Coordenar as ações de resposta frente às necessidades identificadas;
- Prestar apoio técnico, presencial e/ou virtual nas respostas às emergências em saúde pública;
- Convocar áreas técnicas afins para auxiliar no desenvolvimento das ações emergenciais;
- Acompanhar sistemas de alerta e alarme.
- Realizar, em parceria com as áreas técnicas, levantamento e análise do perfil epidemiológico da população, dos recursos disponíveis no setor saúde, e a

identificação das necessidades;

- Elaborar boletim informativo sobre a situação da emergência e sobre ações desenvolvidas nasesferas de gestão do SUS;
- Orientar e acompanhar, em parceria com as áreas técnicas, os indicadores epidemiológicosrelacionados a seca dos municípios e Estado;
- Monitorar o nível dos rios e chuvas;
- Subsidiar a tomada de decisão para acionamento do Ministério da Saúde e/ou a ForçaNacional do SUS;
- Subsidiar a tomada de decisão para acionamento do Ministério da Saúde e/ou a Força Nacional do SUS;
- Intensificar o apoio e o envio de equipes de resposta à Emergência em Saúde Pública (ESP) da Vigilância em Saúde, para avaliar o cenário e dimensionar os recursos adicionais (materiais ehumanos) necessários no âmbito das Secretarias Municipais de Saúde;
- Emitir alertas para a Secretaria de Estado de Saúde, que por sua vez enviará para as Secretarias Municipais de Saúde sobre a situação epidemiológica das doenças relacionadas àESP.

6.4 CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR – CEREST

A Vigilância em Saúde do Trabalhador compreende um conjunto de práticas sanitárias contínuas e sistemáticas, ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções sobre esses aspectos, de forma a reduzi-los ou eliminá-los e promover a saúde.

Numa situação de emergência ou desastre deve-se ter o cuidado com os profissionais das diversas áreasenvolvidas e, especialmente os da área da saúde, que se envolvem nas atividades de atendimento e atenção aosatingidos/afetados.

É através de um conjunto de ações educativas, promocionais e preventivas que os profissionais da saúdepodem se preparar melhor para atuação na área de desastres, minimizando e evitando agravos à saúde relacionados a esses trabalhos.

Ações:

- Conhecer o território (região);
- Conhecer o histórico de desastres naturais (seca e estiagem) do território;
- Conhecer os dados epidemiológicos do território;
- Ter uma relação dos profissionais que farão os atendimentos em caso de desastre. VII;
- Verificar e solicitar a imunização (cartão de vacinação) dos trabalhadores envolvidos nosatendimentos relacionados aos desastres;
- Capacitar previamente as equipes de saúde para realizar o atendimento nessas

situações, porém com os cuidados devidos para com a sua própria saúde;

- Realizar rodas de conversas sobre cuidados necessários em saúde mental e/ou situações de desastres relacionados a queimadas;
- Promover conhecimento a todos os trabalhadores sobre os possíveis agravos à saúde decorrentes de sua atividade profissional em uma situação de emergência;
- Acompanhar a saúde dos trabalhadores (bombeiros, defesa civil, pescadores, saúde, e etc.) que foram expostos aos riscos decorrentes dos desastres durante sua atividade profissional;
- Monitorar o efeito dos desastres sobre a saúde dos trabalhadores que exerceram suas atividades no período do evento, por meio do processamento de informações de rotina sobre agravos ou acidentes relacionados ao trabalho;
- Estabelecer ações interdisciplinares e intersetoriais na discussão e no enfrentamento dos impactos do trabalho em situação de emergência;
- Implementar as ações de vigilância em Saúde do Trabalhador nos diversos níveis de atenção do SUS, articulando com as demais vigilâncias;
- Estabelecer fluxos de referência e contrarreferência articulados para a atenção à saúde dos profissionais envolvidos;
- Prover e treinar para o uso de equipamentos de proteção individual e coletivo;
- Avaliar os danos e gerenciar o risco em parceria com as demais vigilâncias;
- Monitorar em conjunto com os órgãos/instituições de meio ambiente o processo de limpeza e recuperação de áreas afetadas por queimadas.

6.5 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

- Orientar as Vigilâncias Sanitárias municipais, a integração dos trabalhos e o apoio à vigilância ambiental;
- Elaborar o diagnóstico sanitário dos municípios em situação de risco para seca, no tocante ao saneamento básico, resíduos sólidos, drenagem, serviços de saúde, comércio e centrais de alimentos;
- Monitorar a qualidade da água potável distribuída emergencialmente por meio de barreiras sanitárias, verificando os carros-pipa credenciados pelo Exército, Prefeituras Municipais, entre outros;
- Garantir a coleta e o envio de amostras de alimentos e medicamentos para análise laboratorial, quando necessário;
- Avaliação e gerenciamento de risco à saúde imposta pelas condições sanitárias por

formas de abastecimentos;

- Divulgação de informação à população sobre a qualidade da água e os riscos à saúde;
- Apoio às ações de educação em saúde e mobilização social;
- Elaborar, em conjunto com os responsáveis pelo sistema, solução alternativa coletiva de abastecimento de água, plano de ação contendo a definição de estratégias e atividades para a minimização de risco à saúde;
- Realizar inspeções sanitárias das formas de abastecimento de água, em especial das soluções alternativas utilizadas para abastecimento emergencial como poços, cacimbas, chafarizes e carros-pipa e, quando necessário, proibição temporária do uso, até que sejam realizadas melhorias das condições sanitárias;
- Identificar outras fontes seguras para a população, quando necessário, mesmo que em outros municípios;
- Apoiar ações em saúde juntamente com os demais profissionais de saúde e os responsáveis pelo abastecimento de água, limpeza e desinfecção de reservatórios e tratamento intradomiciliar de água para consumo humano (filtração e acréscimo de duas gotas de solução de hipoclorito de sódio a 2,5% a cada um litro de água ou, em caso de indisponibilidade deste produto, realização de filtração seguida de fervura);
- Definir fontes prioritárias para o abastecimento dos carros pipa, priorizando a captação em Estação de Tratamento de Água com tratamento convencional e, quando não for possível, priorizar a captação em mananciais subterrâneos ou superficiais e realizar o tratamento mínimo por meio de filtração e desinfecção antes da distribuição para a população;
- Participar dos Comitês de Combate à seca nos locais onde estiverem instituídos;
- Solicitar que os responsáveis pelo sistema ou pela solução alternativa coletiva de abastecimento de água monitorem de forma sistemática a concentração de cianobactéria nos pontos de captação dos mananciais superficiais e aprimorem o controle operacional da Estações de tratamento de Água, incluindo lavagens mais frequentes dos filtros rápidos para se evitar o acúmulo de algas cianobactérias no leito filtrante, que pode acarretar a liberação de cianotoxinas na água tratada; e,
- Manter articulação com unidades de emergência (hospital e pronto atendimento) para alertar sobre o possível aumento no número de casos de doenças de transmissão hídrica, especialmente Doença Diarréica Aguda, e aumento do número de casos de transtornos psicossociais e comportamentais;

6.6 DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

É pertinente que haja avaliação epidemiológica, tendo em vista que todos os anos, nesse período sazonal, existe aumento de doenças respiratórias por conta de queimadas. A Divisão tem instrumento próprio para a coleta de dados de IVAS e IRAS durante o ano, com dados por: município, data, semana epidemiológica, sexo, bairros e diagnostico.

Desta feita, no intuito de fortalecer as ações contidas no Plano de Contingência, no que compete a estaárea técnica, recomenda-se:

- Intensificar a digitação e o encaminhamento para a Divisão de Sistema de Informação emVigilância, uma vez que este instrumento já existe;
- A correta digitação e a completude dos campos;
- Envios semanais para o e-mail gerencia.dsis@gmail.com, para a consolidação dos dados.

6.7 LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA – LACEN/AC

- Garantir o aporte laboratorial para confirmação diagnóstica, orientando a coleta, fluxo de encaminhamento de amostras e resultados dos laboratórios de Virologia, Imunologia, Endemias, Parasitologia,Bacteriologia, Bromatologia e Ambiente;
- Comunicar às Coordenações dos agravos e ao CIEVS estadual, de forma efetiva, informações relacionadas aos diagnósticos laboratoriais de saúde pública, independentemente de constar na lista nacional de agravos de notificação compulsória;
- Notificar os eventos que possam constituir emergência, caso incomum ou inesperado que podeter grave impacto sobre a saúde pública.

6.8 DIVISÃO DE IMUNIZAÇÃO – PNI/AC

- Orientar as Secretarias Municipais de Saúde nas recomendações específicas sobre Vacinaçãoem caráter emergencial;
- Disponibilizar insumos necessários para manter a rede de frios, caso haja aumento dademanda;
- Organizar a distribuição de insumos estratégicos conforme as necessidades locais.

7. DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

- Orientar os municípios na elaboração dos Planos de Contingência;

- Verificar junto aos municípios quantidade de equipes da estratégia saúde da família e de atenção primária completas e ativas, com cumprimento da carga horária;
- Qualificar os profissionais da Atenção Primária à Saúde com foco nas ações de educação em saúde;
- Fortalecer o Programa Telessaúde e Telemedicina nos municípios;
- Orientar os municípios na promoção do aleitamento materno exclusivo (0 a 6 meses) e complementar (a partir dos 6 meses);
- Incentivar e promover a suplementação profilática de Vitamina A (6 meses e4 anos, 11 meses e 29 dias) e Ferro (6 meses a 2 anos);
- Orientar os municípios na realização de ações de educação com foco na prevenção, promoção da saúde através de palestras e distribuição de materiais educativos (folders, cartilhas, spots de rádio, etc.);
- Orientar os municípios para intensificar as visitas domiciliares e orientações aos usuários quanto ao uso correto e racional da água;
- Assessorar a gestão municipal na construção/ atualização dos fluxos de referência e contrarreferência da estratégia de saúde da família para médiae alta complexidade;
- Orientar a realização de busca ativa de casos de pessoas em situação de maior vulnerabilidade (idosos, crianças, gestantes, portadores denecessidades especiais, doentes crônicos, etc.);
- Orientar os municípios para garantir 1ª etapa de terapia de reidratação oral na estratégia de saúde da família;
- Orientar os municípios para instalar/ reativar salas de observação nas unidades básicas de saúde para garantir reidratação venosa aos pacientes;
- Orientar a confecção de material informativo sobre recomendações pararealizar atividade física nas academias e ao ar livre, ingesta hídrica e alimentação saudável;
- Elaborar instrutivos de consulta rápida com abordagem sindrômica para detecção e manejo de sintomas respiratórios aos profissionais de saúde, para disponibilizar nas unidades de saúde;
- Fomentar a importância da garantia de medicamentos (esteroides inalatórios, antibióticos, e outros) para o tratamento das doenças respiratórias crônicas nas unidades de saúde;
- Promover ações de educação permanente para a construção de habilidades, competências e cuidado interdisciplinar dos profissionais da APS

na prevenção e no manejo de doenças crônicas respiratórias mais prevalentes, tais como Asma e DPOC;

- Intensificar estratégias intersetoriais de promoção da saúde, prevenção e estímulo à cessação do uso de produtos derivados de tabaco, bem como quanto ao combate à iniciação ao fumo;
- Orientar a realização da vigilância alimentar e nutricional regular às pessoas com situação de maior vulnerabilidade;
- Fomentar junto ao Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) do PSE de cada município, a importância de se priorizar ações voltadas para a classe estudantil abordando temas como higiene alimentar e pessoal; os principais problemas respiratórios devido à baixa umidade do ar e as Doenças Diarreicas Agudas e Desidratação.

8. COMUNICAÇÃO

- Divulgar materiais educativos (cartilhas e folders) no sítio eletrônico da Secretaria da Saúdedo Acre (SESACRE);
- Divulgar amplamente nas mídias locais, por meio de parcerias com empresas de comunicação (portais de internet, veículos de imprensa, operadores de telefonia, entre outros) para dar suporte à divulgação de informações úteis à sociedade;
- Monitorar a situação de adoecimento da população em virtude de enchentes e inundações,junto ao CIEVS, para avaliar estratégias de comunicação adequadas (envio de pautas, coletivas de imprensa e ações de mobilização social);
- Manter interface com a Ouvidoria;

9. GESTÃO

- Articular com os diretores e coordenadores da SES, estratégias de atuação para o atendimentooportuno à ESP;
- Articular o envio de recursos adicionais (materiais e humanos) para o atendimento à ESP;
- Acompanhar o desenvolvimento das ações de saúde estabelecidas no Plano de ContingênciaEstadual por Seca e Estiagem;
- Garantir o envio de equipe à campo, quando necessário;
- Participar das reuniões do CME, garantindo a resolução de conflitos e dificuldades encontradasna resposta à ESP;
- Apoiar o desenvolvimento das ações previstas no plano de ações.

10. OUVIDORIA

- Divulgar, conforme sua abrangência de atuação, as orientações técnicas da Secretaria da Saúdedo Acre (SESACRE) à população em geral;
- Colaborar na notificação de eventos repassando imediatamente qualquer comunicação advinda da população quanto ao atendimento na rede de saúde (falta de soros, atendimento precário, remoções desnecessárias, entre outros) ao CIEVS.

11. ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Ações de Competência da Diretoria de Gerenciamento de Unidades Próprias (DGUP):

- Identificar Unidades de Saúde em condições de atendimento e acesso à população afetada (Unidades Públicas e Conveniadas);
- Identificar hospitais de referência para os casos que necessitem de cuidados intermediários na região ou em outras regionais próximas;
- Garantir a notificação dos casos de doenças de notificação compulsória;
- Garantir profissionais para os atendimentos emergenciais de gravidade, dentre os profissionais já existentes no quadro de servidores;
- Divulgar para a rede de assistência regional de saúde os fluxogramas de atendimento dedoenças e agravos relacionados com os desastres de origem natural, preconizados pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde;
- Organizar escala de plantão dos profissionais para o atendimento hospitalar e garantir seu cumprimento;

Ações de Competência de Outros Setores da Assistência:

- Contratação, se necessário, de leitos das unidades privadas de saúde;
- Levantar necessidade de leitos para o atendimento aos principais agravos;
- Identificar leitos para atendimento em Unidade de Tratamento Intensivo;
- Garantir leitos de retaguarda para pacientes agudos e crônicos;
- Garantir medicamentos e insumos para as principais gravidades;
- Manter nos hospitais de referência estoques de medicamentos.

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental dos Riscos Decorrentes dos Desastres Naturais – Vigidesastres.** Brasília: Secretaria de Vigilância em Saúde, 2006.

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. **Guia de vigilância epidemiológica**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf

3. BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador. **Plano de Contingência para Emergência em Saúde Pública por Seca e Estiagem.** Brasília, 2015. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_contingencia_emergencia_seca_estiagem.pdf

4. FREITAS Carlos Machado et al, Enchentes e Saúde Pública - **Uma Questão na Literatura Científica Recente das Causas, Consequências e Respostas para Prevenção e Mitigação**. Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, 2012. Disponível em:https://www.scielosp.org/article/csc/2012.v17n6/1601-1616/

5. **Plano Estadual de Saúde do Acre – PES 2020-2023 – VF** - www.conass.org.br, 2023. Disponível em: <https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2016/04/PLANO-ESTADUAL-DE-SAUDE-PES-2020-2023-VF.pdf> . Acesso em: 21 de janeiro de 2023